

# La mirada del terapeuta en las primeras tres sesiones

*Terapia de pareja de orientación psicoanalítica y psicología del self, con una pareja que además es parental (padres con hijos).*

TWIM Project · Daniel Orozco Abia · Psicólogo General Sanitario CV11515 — material de estudio para psicólogos que empiezan en terapia de pareja

## Nota de honestidad · léela antes que nada

Este texto es una **guía de estudio**, no un protocolo ni un manual de instrucciones. Lo que describe son **modelos teóricos** —maneras de mirar— contruidos por clínicos a lo largo de un siglo. Son lentes útiles, no verdades demostradas como las de la física: distintas escuelas miran lo mismo y lo nombran distinto, y a veces se contradicen (lo verás señalado en el §7).

Tres compromisos de veracidad con quien lee:

- **Cada idea relevante va atribuida a su autor y a la obra concreta** de donde procede. Cuando una expresión va entre comillas y en cursiva, es un término técnico reconocido de ese autor (p. ej. la «introspección vicaria» de Kohut), no una invención. No incluyo números de página que no pueda sostener; cuando un concepto es de atribución amplia, lo digo.

- **Las citas se han verificado** (autor, título, año, editorial) en junio de 2026. La bibliografía completa, comentada, está en el §8.

- **Todos los ejemplos clínicos son hipotéticos o compuestos.** No reproducen a ninguna pareja real. Sirven para ilustrar un mecanismo, no para retratar a nadie.

Y el límite más importante: **esto no sustituye a la formación supervisada**. Un texto enseña a mirar; solo la supervisión enseña a sostener lo que se ve. Empezar en terapia de pareja sin supervisión es el error que

ninguna guía puede corregir.

## Contenido

1. ¿Quién es el paciente? La pareja —el vínculo— como unidad de tratamiento.
2. La mirada: la empatía como instrumento de observación (Kohut).
3. El tercero y el espacio triangular: por qué el terapeuta no toma partido (Britton).
4. Qué mira el terapeuta a través de la teoría: ajuste, colusión, identificación proyectiva, dimensión selfobject, fantasmas, lo parental.
5. Las primeras tres sesiones, una a una: objetivos, qué escuchar, postura, intervenciones, errores y fundamento.
6. La disciplina interna del terapeuta (transversal a las tres sesiones).
7. Mapa de escuelas y desacuerdos (qué integra esta guía y desde dónde).
8. Bibliografía comentada · las fuentes.

## 1 · ¿Quién es el paciente?

El cambio de mirada que lo decide todo

La primera decisión de un terapeuta de pareja no es qué decir, sino **a quién mira**. Y la respuesta no es obvia: el paciente no es ella, no es él, ni siquiera son «los dos». El paciente es **el vínculo** —eso que existe entre ambos y que ninguno controla del todo—.

Quien viene de la terapia individual trae un reflejo automático: escuchar a una persona, entender su mundo, ayudarla. En la pareja, ese reflejo es una trampa. Si el terapeuta escucha a dos individuos por turnos, acaba siendo árbitro («¿quién tiene razón?») o juez de turno, y la pareja lo expulsa o lo absorbe. El giro consiste en mirar lo que ocurre *entre* los dos como si fuera un tercer paciente con su propia historia, su propia lógica y su propio inconsciente.

Esta idea tiene padres concretos. **Henry Dicks**, en el Tavistock, fue de los primeros en proponer que la pareja forma lo que llamó una «*personalidad marital conjunta*» (Dicks, *Marital Tensions*, Routledge/Tavistock, 1967): integró la teoría de la estructura psíquica de Fairbairn con la identificación proyectiva de Klein y planteó **la pareja como unidad de estudio**, no como suma de dos. En la tradición argentina, **Janine Puget e Isidoro Berenstein** lo formularon como «*lo vincular*»: la pareja se sostiene sobre acuerdos y pactos inconscientes y sobre un «*zócalo inconsciente*» compartido (Puget & Berenstein, *Psicoanálisis de la pareja matrimonial*, Paidós, 1988). Y en el Tavistock contemporáneo, **Mary Morgan** lo nombra como «*un estado mental de pareja*» (*a couple state of mind*): la capacidad —del terapeuta y, con el tiempo, de la propia pareja— de pensar la relación como un tercero, en vez de como un campo de batalla entre dos yoes (Morgan, *A Couple State of Mind*, Routledge, 2019).

## Fundamento

«El paciente es el vínculo» no es una metáfora bonita: es la decisión técnica que organiza todo lo demás. Define a quién dirigir las intervenciones (al «nosotros», no a uno), qué transferencia se observa (la de la pareja hacia el terapeuta, además de la de cada uno) y qué se interpreta (la dinámica compartida, no la culpa individual).

Dicks (1967) · Puget & Berenstein (1988) · Morgan (2019).

Cuando la pareja es además **parental** —tienen hijos—, hay un segundo vínculo dentro del primero: el de los dos como padres. No es lo mismo el vínculo conyugal (los dos como amantes) que el vínculo parental (los dos como equipo que cría). Buena parte de los conflictos que llegan a consulta viven justo en la frontera entre ambos: lo no resuelto en la pareja se descarga en la crianza, o al revés. El terapeuta tiene que mirar los dos vínculos a la vez sin confundirlos —volveremos a esto en el §3 y en el §4.5—.

## 2 · La mirada

### La empatía como instrumento de observación, no como amabilidad

La psicología del self aporta a la terapia de pareja su herramienta central, y conviene entenderla bien porque casi siempre se malinterpreta. Para **Heinz Kohut**, la empatía no es ser cálido ni «ponerse en el lugar del otro» como

gesto moral: es un **método de recogida de datos**. La definió como «*introspección vicaria*» (*vicarious introspection*): la capacidad de pensar y sentir el mundo interno de otro *desde dentro*, como vía de acceso a una realidad psíquica que de otro modo es invisible (Kohut, «*Introspection, Empathy, and Psychoanalysis*», *JAPA*, 1959; y *The Analysis of the Self*, International Universities Press, 1971).

Dicho de otro modo: en la pareja, la empatía es el microscopio. Sin ella, el terapeuta solo ve la superficie de la pelea (quién dijo qué). Con ella, accede a lo que cada uno *siente* que le pasa al estar con el otro: la herida, el miedo, la necesidad no vista. Y aquí está la dificultad que separa la terapia de pareja de la individual: **hay que sostener la empatía con los dos a la vez**, sin que uno sienta que el terapeuta «se va con» el otro. Es una doble inmersión simultánea, y es la habilidad más difícil del oficio.

## El concepto que lo articula todo: el selfobject

Kohut observó que el ser humano no «supera» la necesidad del otro al madurar: la transforma. A lo largo de toda la vida necesitamos a otros que cumplan funciones psíquicas para sostener nuestro sentido del propio valor. A esas personas-en-función las llamó **objetos del self** (*selfobjects*) —glosa llana: *alguien a quien usamos, sin saberlo, para sentirnos enteros*—. Describió sobre todo tres funciones (Kohut, *The Analysis of the Self*, 1971; *The Restoration of the Self*, IUP, 1977):

- **Réplica / función especular** (*mirroring*): que el otro me devuelva con su mirada que lo que soy y lo que hago vale. El brillo en los ojos de quien me mira.
- **Idealización**: poder admirar al otro y sentirme calmado por pertenecer a algo más grande y fuerte que yo.
- **Gemelaridad / alter ego** (*twinsip*): sentir que hay alguien esencialmente como yo, que el otro «es de los míos».

La traducción a la pareja la hizo de forma magistral **Marion Solomon**. Su tesis, casi un axioma del campo: **no hay amor adulto en el que el ser amado no sea también un objeto del self** —no hay relación de amor sin réplica y sin idealización mutuas que sostengan la autoestima de ambos— (Solomon, *Narcissism and Intimacy: Love and Marriage in an Age of Confusion*, W. W. Norton, 1989). De ahí su definición de lo que cura: la terapia de pareja ayuda a los miembros a **aprender a ser objetos del self el uno del otro**, reparando estructuras dañadas del self.

### Qué hace el terapeuta con esto, ya en la sesión 1

Deja de oír la pelea como un choque de hechos («tú llegaste tarde» / «tú no me avisaste») y empieza a oírla como **un fallo de función selfobject**: «cuando llegas tarde, ella no recibe la mirada que le dice que importa»; «cuando él calla, no encuentra a nadie a quien admirar ni de quien sentirse parte». La discusión por la superficie casi nunca es por la superficie.

## 3 · El tercero y el espacio triangular

Por qué el terapeuta no puede colapsar en un bando — y por qué esto importa el doble con una pareja parental

Si la empatía doble es el instrumento, **el «tercero» es la posición desde la que se sostiene**. El concepto procede de **Ronald Britton**, en la tradición kleiniana. Britton describió el «*espacio triangular*» y la «*tercera posición*»: la capacidad psíquica de observar una relación de la que *no* formas parte, de ser testigo y no participante. Su formulación es notable justamente porque parte de la **pareja parental**:

*Si el vínculo entre los padres, percibido en el amor y en el odio, puede ser tolerado en la mente del niño, le proporciona el prototipo de una relación de objeto de un tercer tipo, en la que es testigo y no participante. Entonces nace una tercera posición desde la cual pueden observarse las relaciones de objeto.*

Britton, «The Missing Link: Parental Sexuality in the Oedipus Complex», en J. Steiner (ed.), *The Oedipus Complex Today: Clinical Implications*, Karnac, 1989, pp. 83–101 (paráfrasis del pasaje central).

Esto tiene una doble lectura que conviene no perder, porque es lo que hace tan rica la terapia con una pareja que es parental:

- **Para el terapeuta:** su trabajo es ocupar y sostener la tercera posición. Estar con cada uno sin ser de ninguno; mirar el vínculo desde fuera sin caer dentro de la pelea. Cada vez que el terapeuta «toma partido», pierde el tercero y se vuelve un personaje más del conflicto. **Thomas Ogden** nombró algo afín en la propia relación analítica: el «*tercero analítico*», una experiencia co-creada por paciente y analista que es más que la suma de ambos (Ogden, «The Analytic Third», *IJP*, 1994; *Subjects of Analysis*, Karnac, 1994).
- **Para la pareja:** aquello que Britton describe en el niño es exactamente lo que muchas parejas en conflicto han perdido entre ellos —la capacidad de mirar su propia relación desde fuera en vez de estar atrapados dentro de ella—. Mary Morgan llama a la versión sana de esto «*la pareja creativa*» (*the creative couple*): dos que pueden pensar juntos sobre lo que les pasa, en lugar de embestirse (Morgan, *A Couple State of Mind*, 2019). Y como son padres, esa capacidad —o su ausencia— se transmite: la pareja parental que no tolera su propio vínculo le niega al hijo el prototipo del tercero. El conflicto conyugal y la salud psíquica del hijo no están en habitaciones separadas.

### Error frecuente del que empieza

Creer que «ser imparcial» es repartir el tiempo a partes iguales o darle la razón a los dos. La tercera posición no es equidistancia diplomática: es una postura interna que permite empatizar profundamente

con cada uno y *al mismo tiempo* seguir viendo el patrón que comparten. Se puede estar intensamente con el dolor de ella en un minuto y con el de él al siguiente sin haber abandonado el vínculo. Lo que no se puede es aliarse con uno contra el otro —ni siquiera cuando uno «tiene más razón»—.

## 4 · Qué mira el terapeuta a través de la teoría

### Cinco lentes que convierten una pelea en información

Las tres primeras sesiones no son para arreglar nada. Son para **ver**. Y para ver hace falta saber qué se está buscando. Estas cinco lentes son lo que el terapeuta tiene en la cabeza mientras escucha. No se aplican como un cuestionario: se llevan puestas.

### 4.1 · El ajuste inconsciente y la colusión

La pregunta «¿por qué estos dos, precisamente?» casi nunca tiene una respuesta consciente suficiente. Dicks observó que los miembros de una pareja encajan a niveles inconscientes: cada uno responde, sin saberlo, a una **imagen interna superpuesta sobre el otro** —una versión de un padre, de un figura temprana, de un pacto antiguo— (Dicks, *Marital Tensions*, 1967). No se eligen a pesar de sus heridas: muchas veces se eligen *por* ellas, porque encajan como dos piezas cóncava y convexa.

El psiquiatra suizo **Jürg Willi** dio a ese encaje un nombre que ha hecho fortuna: **colusión** (*Kollusion*). La colusión es un juego inconsciente compartido en el que ambos participan desde polos opuestos de un mismo tema no resuelto —por ejemplo, uno hace de fuerte y autosuficiente y el otro de débil y necesitado, y ambos evitan así enfrentarse a la dependencia que asusta a los dos— (Willi, *Couples in Collusion*; orig. alemán 1975, ed. inglesa Jason Aronson, 1982). Willi, conviene decirlo con honestidad, integró lo psicodinámico con lo sistémico: su «colusión» es un puente entre escuelas, no psicoanálisis puro.

Puget y Berenstein lo piensan como **acuerdos y pactos inconscientes**: la pareja se constituye sobre un fondo de acuerdos no hablados («yo sostengo esto si tú sostienes aquello») que, cuando se rompen o se rigidizan, producen el síntoma (Puget & Berenstein, 1988).

### Qué escuchar

La **complementariedad**: dónde encajan demasiado bien. El que «siempre» organiza y el que «nunca» se entera; el que persigue y el que se distancia; el que pone las palabras y el que pone el cuerpo. La queja suele ser justo contra el papel que el otro cumple y *que la propia colusión necesita*. Por eso cambiarlo da tanto miedo a los dos.

## 4.2 · La identificación proyectiva entre los miembros

Es el mecanismo más importante y el más difícil de ver al principio. La **identificación proyectiva** (concepto de **Melanie Klein**, «Notes on Some Schizoid Mechanisms», 1946) describe cómo una persona deposita en otra una parte intolerable de sí misma —y luego la trata, en el otro, como si fuera del otro—. **Wilfred Bion** mostró que no es solo una fantasía intrapsíquica, sino una **comunicación real entre dos mentes**: el otro recibe la proyección y, si puede «contenerla» y devolverla digerida, ayuda; si la actúa, la amplifica (Bion, *Learning from Experience*, Heinemann, 1962).

En la pareja, esto es el pan de cada día: él porta toda la rabia de los dos (y ella «nunca se enfada»); ella porta toda la fragilidad (y él «no siente nada»). Cada uno aloja una parte exiliada del otro. Mary Morgan describió la versión paralizada de este intercambio como «bloqueo proyectivo» (*projective gridlock*): un estado en el que los dos están tan mutuamente identificados por proyección que ninguno puede pensar ni moverse como individuo separado —están pegados, no relacionados— (Morgan, *A Couple State of Mind*, 2019). David y Jill Scharff sistematizaron el trabajo con estos mecanismos en la terapia de pareja de relaciones objetales (Scharff & Scharff, *Object Relations Couple Therapy*, Jason Aronson, 1991).

### Por qué importa para la mirada

Lo que el terapeuta *siente* en la sesión —el aburrimiento, la irritación contra uno, las ganas de rescatar al otro— suele ser información sobre lo que circula entre ellos, no un fallo del terapeuta. Es la identificación proyectiva llegándole también a él. Eso se llama **contratransferencia** y, en pareja, es una de las mejores fuentes de datos (ver §6).

Klein (1946) · Bion (1962) · Scharff & Scharff (1991) · Morgan (2019).

## 4.3 · La dimensión selfobject: los fallos crónicos de réplica

Aplicando la lente de Kohut y Solomon (§2): el terapeuta escucha la relación como una historia de **fallos selfobject repetidos**. No «quién es mala persona», sino dónde dejó cada uno de recibir la réplica, la idealización o la gemelaridad que necesitaba —y cómo esa carencia, repetida, se volvió herida narcisista y luego resentimiento—. Solomon muestra cómo las vulnerabilidades narcisistas de cada uno «encajan» en el sistema marital y cómo el intento de defenderse del daño emocional construye, paradójicamente, las barreras a la intimidad (Solomon, *Narcissism and Intimacy*, 1989).

## 4.4 · Los fantasmas: objetos internos heredados

Cada miembro llega con su «elenco» interno: las figuras de su infancia, vivas dentro, que se proyectan sobre el cónyuge. La imagen más conocida es la de **Selma Fraiberg**: los «fantasmas en la habitación del bebé» (*ghosts*

*in the nursery*) —los padres del pasado que, no recordados, se repiten en el presente— (Fraiberg, Adelson & Shapiro, «Ghosts in the Nursery», *J. Am. Acad. Child Psychiatry*, 14(3), 1975). Honestidad necesaria: ese texto habla del vínculo *padres-bebé*, no de la pareja; pero la metáfora capta con exactitud algo que también ocurre en el matrimonio —uno acaba discutiendo con su madre a través de su mujer, o esperando del marido el reconocimiento que nunca dio el padre—. Dicks lo decía sin metáfora: responden a una imagen internalizada superpuesta sobre el otro (Dicks, 1967).

## 4.5 · La dimensión parental: cuando el hijo entra en la escena

Como la pareja es parental, hay una lente más. El conflicto conyugal rara vez se queda en la pareja: **busca un tercero donde descargarse, y el hijo es el candidato más a mano**. La teoría sistémica lo nombró con precisión —Murray Bowen llamó «*triangulación*» al proceso por el que una tensión entre dos se estabiliza arrastrando a un tercero— (Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, Jason Aronson, 1978). Lo cito con honestidad: es un concepto *sistémico*, no psicoanalítico; pero la mayoría de los terapeutas de pareja psicoanalíticos lo integran porque describe bien lo que ven. La lectura analítica de ese mismo fenómeno la da Britton (§3): el hijo queda atrapado como participante donde debería ser testigo.

Formas concretas en que el hijo aparece en el material de las primeras sesiones:

- **Como portador del síntoma:** «venimos por el niño, que va mal en el cole» —y a la tercera frase la pelea es de ellos dos—. El síntoma del hijo es a veces el billete de entrada de la pareja a la consulta.
- **Como campo de batalla:** la crianza es el terreno donde se libra, desplazada, la guerra conyugal («tú lo consientes» / «tú eres un sargento»).
- **Como estabilizador:** el hijo une lo que la pareja ya no une; ocuparse de él permite no mirarse.

### Qué hace el terapeuta

Anota la aparición del hijo, pero **devuelve el foco al vínculo de los padres** sin desentenderse del niño. Una formulación útil que sostener internamente: «*lo mejor que puedo hacer por vuestro hijo es ayudaros a vosotros dos a recuperar vuestro vínculo*». Distinguir siempre el sub-vínculo conyugal del parental (§1) y vigilar por cuál de los dos entra el dolor.

## 5 · Las primeras tres sesiones, una a una

El núcleo práctico — qué hacer, qué escuchar, qué evitar



Aviso antes de entrar: «tres sesiones» es una división didáctica, no un calendario. Hay parejas que en la primera entrega ya todo el material y otras que tardan cinco encuentros en dejar de actuar para el terapeuta. La secuencia que sigue describe un *orden lógico* de tareas —encuadrar, comprender, formular— que se cumple en ese orden aunque los tiempos varíen. Úsala como brújula, no como reloj.

## Sesión 1 · Acoger, encuadrar y leer la primera escena

Objetivo: que la pareja se sienta vista (los dos), establecer el marco, y observar —más que intervenir— cómo es estar juntos.

### a) El encuadre: lo que se decide antes de empezar a hablar

El **encuadre** (las reglas del marco: frecuencia, duración, honorarios, quién es el paciente, qué se hace con lo que cada uno cuenta) no es burocracia previa: es parte del tratamiento. **José Bleger** mostró que el encuadre funciona como una «*institución muda*» que sostiene en silencio el proceso y que se vuelve depositaria de las partes más primitivas del vínculo; por eso, cuando se rompe, se rompe mucho más que una norma (Bleger, «Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico», 1967; en *Simbiosis y ambigüedad*, Paidós, 1967).

Dos decisiones de encuadre que en pareja no se pueden improvisar:

- **Quién es el paciente:** dejarlo explícito —«mi paciente es vuestra relación; no estoy aquí para decidir quién tiene razón»—. Esto inaugura la tercera posición (§3) desde el minuto uno.
- **Qué se hace con los secretos:** es una decisión técnica con dos escuelas, y conviene tomarla a conciencia. La *política de no-secretos* (lo que me cuente uno a solas podré usarlo en el trabajo común) protege el vínculo de quedar dividido y al terapeuta de volverse cómplice; la *confidencialidad individual* permite que aflore material que de otro modo no saldría, a cambio de cargar al terapeuta con secretos. No hay respuesta única: hay que **elegir una postura y decírsela a la pareja antes de que haya secretos que guardar**.

### b) La primera escena: mirar antes de escuchar

Antes de la primera palabra ya hay datos. ¿Quién entra primero? ¿Quién elige el sitio? ¿Quién habla y quién espera a ser hablado? ¿Se miran entre ellos o solo te miran a ti? La **coreografía implícita** de la pareja dice más que el motivo de consulta. El terapeuta, en la sesión 1, observa más de lo que interviene.

### c) La demanda: lo que piden por fuera y lo que piden por dentro

Hay que distinguir la **queja manifiesta** («discutimos por todo», «no hay sexo», «el niño va mal») de la **demandas latente**: para qué vienen *de verdad*, que casi nunca es lo que dicen y que a veces ni ellos saben. A veces vienen a que el terapeuta confirme que la culpa es del otro; a veces, a separarse con un testigo; a veces, a que alguien por fin mire el vínculo. Leer la demanda real es la mitad del trabajo de la primera sesión.

## d) La empatía con los dos, y la transferencia que ya empezó

La tarea emocional de la sesión 1 es que **cada uno se vaya sintiendo que el terapeuta entendió algo de su mundo** —sin que el otro sienta abandono—. Es la empatía doble de Kohut (§2) puesta a prueba. Y mientras eso ocurre, ya se está montando la **transferencia**: hacia el terapeuta (como selfobject esperado, como juez temido, como padre/madre del que se espera reparto de razón) y la *transferencia de la pareja como unidad*.

El terapeuta nota también su **contratransferencia** de inmediato: las ganas de proteger a uno, la antipatía hacia el otro, el impulso de aconsejar. **Joseph Sandler** lo explicó como «*responsividad de rol*» (*role-responsiveness*): el paciente —aquí, la pareja— tiende a «asignar» al terapeuta un papel en su guion, y el terapeuta se descubre a punto de interpretarlo (Sandler, «Countertransference and Role-Responsiveness», *Int. Rev. Psychoanal.*, 1976). Verlo a tiempo es no actuarlo.

### Ejemplo hipotético (no es una pareja real)

Ella habla diez minutos; él mira por la ventana. Cuando él por fin dice algo, ella suspira y completa su frase. El terapeuta nota dos cosas en sí mismo: ganas de «rescatar» a él para que hable, e irritación con ella por no dejarle. Esa irritación no es un fallo: es la primera muestra de cómo se reparten los papeles en esta pareja —ella, la que pone todas las palabras; él, el que se ausenta— y de cómo el vínculo intenta colocar al terapeuta en el papel de quien por fin «le da voz al callado». Nombrarlo en la cabeza, no actuarlo todavía.

### Errores frecuentes en la sesión 1

Lanzarse a interpretar o a dar herramientas (es pronto: aún no se ha ganado el vínculo). Aliarse con el que «sufre más» o con el que «habla mejor». Prometer, sin querer, que se va a dictaminar quién tiene razón. Dejar el encuadre sin decir, sobre todo la política de secretos. Tomar el motivo de consulta literal y no escuchar la demanda latente.

## Sesión 2 · Escuchar el vínculo por debajo de la pelea

Objetivo: pasar del contenido (por qué se pelean) al proceso (cómo funcionan juntos). Empezar a oír la colusión, la identificación proyectiva y la historia.

### a) Que la colusión se haga audible

En la segunda sesión, si la primera hizo bien su trabajo, la pareja repite delante del terapeuta su escena típica. Ahí el terapeuta busca la **complementariedad** (§4.1): el encaje demasiado perfecto de papeles opuestos. No se trata de señalarlo aún como una interpretación cerrada, sino de **recogerlo y empezar a describir el patrón** en voz

alta, con cuidado y repartido entre los dos.

#### Fraseo posible (orientativo, no fórmula)

*«Me fijo en algo que os pasa: cuanto más insiste ella en acercarse, más necesita él poner distancia; y cuanto más se aleja él, más tiene ella que insistir. Parece que estáis los dos atrapados en la misma rueda, cada uno empujando desde su lado.»* — Nótese: describe un movimiento **de los dos**, no acusa a ninguno. Eso es interpretar el vínculo, no a la persona (volveremos en §5, sesión 3).

### b) La identificación proyectiva, ahora en vivo

Con la lente del §4.2, el terapeuta empieza a ver quién aloja qué para el otro: quién porta toda la rabia, quién toda la fragilidad, quién todo el deseo, quién toda la sensatez. La señal más fiable sigue siendo su propia contratransferencia: si se descubre exasperado con uno y protector con el otro, probablemente esté recibiendo la misma proyección que circula entre ellos (Bion, §4.2). Cuando el intercambio está paralizado —ninguno puede pensarse como separado— es el «bloqueo proyectivo» de Morgan (Morgan, 2019).

### c) La historia y la repetición: aparecen los fantasmas

Es el momento de escuchar de dónde viene cada uno. No como anamnesis de formulario, sino atento a **la repetición**: en qué se parece esta pelea a una escena de su familia de origen; a quién está tratando cada uno, sin saberlo, cuando trata al otro (los fantasmas de §4.4; la imagen interna superpuesta de Dicks). Aquí la pareja parental ofrece un material precioso: cómo fueron criados ilumina cómo crían y cómo se tratan.

### d) La lectura selfobject

En paralelo, el terapeuta traduce todo a la clave de Kohut–Solomon (§4.3): ¿dónde dejó cada uno de recibir réplica, idealización o gemelaridad?, ¿qué herida narcisista quedó?, ¿cómo el blindaje contra ese dolor se volvió la barrera a la intimidad? (Solomon, 1989). Esta lectura es la que permite que, más adelante, la terapia ayude a los dos a *volver a ser objetos del self el uno del otro*.

### e) La dimensión parental y el hijo triangulado

Si hay hijos, en la sesión 2 suele verse cómo el conflicto conyugal se descarga en la crianza (§4.5): la triangulación de Bowen, la pérdida del «tercero» de Britton. El terapeuta escucha si el hijo es portador del síntoma, campo de batalla o estabilizador, y guarda esa lectura sin convertir todavía la terapia de pareja en terapia familiar.

Ejemplo hipotético (no es una pareja real)

Él cuenta que su padre era frío y exigente y que él «se prometió no ser así». Ella, que en su casa nadie ponía límites y todo era caos. Hoy pelean porque él es «un sargento» con el hijo y ella «lo deja todo pasar». Mirado por debajo: cada uno cría *contra* su propia infancia y *contra* el otro; él pone en ella el caos que teme, ella pone en él la frialdad que sufrió. El hijo recibe las dos proyecciones. No es un desacuerdo educativo: es dos historias chocando en el cuerpo de un niño.

## Errores frecuentes en la sesión 2

Quedarse en el contenido («hablemos del reparto de tareas») sin escuchar el proceso. Hacer una interpretación profunda y prematura que uno de los dos vivirá como acusación. Convertir la sesión en una anamnesis individual de cada uno por turnos (vuelve a partir el vínculo). Entusiasmarse con el material del hijo y abandonar el foco de la pareja.

## Sesión 3 · Formular, devolver y acordar el trabajo

Objetivo: tener una hipótesis del vínculo, devolverla de forma que los una en vez de enfrentarlos, decidir la indicación y construir una alianza con la pareja como unidad.

### a) La formulación del vínculo

Hacia la tercera sesión el terapeuta debería poder formular, para sí mismo, una **hipótesis del vínculo**: la fantasía inconsciente compartida, la colusión central, el pacto que se rompió, los fallos selfobject recíprocos. No es un diagnóstico de cada uno: es una historia *del par*. Una buena formulación de pareja se reconoce porque, al enunciarla, **ninguno de los dos queda como el culpable** —los dos se reconocen dentro—.

### b) Interpretar el vínculo, no a las personas

Esta es la regla técnica que más distingue a la terapia de pareja psicoanalítica. La intervención se dirige al «**nosotros**», al sistema, al movimiento compartido —no a la psicopatología de uno—. Interpretar a un individuo en presencia del otro lo humilla y rompe la tercera posición (§3); interpretar el vínculo los incluye a ambos como co-autores. Puget y Berenstein, Morgan y los Scharff coinciden en esto desde tradiciones distintas (Puget & Berenstein, 1988; Scharff & Scharff, 1991; Morgan, 2019).

## Fraseo posible (orientativo)

*«Os propongo una manera de entender lo que os pasa. Los dos crecisteis aprendiendo que mostrar necesidad era peligroso —cada uno por razones distintas—. Así que montasteis, sin daros cuenta, un*

*acuerdo: ninguno pide directamente, los dos esperan que el otro adivine, y cuando no adivina, llega el reproche. No es que uno falle al otro: es que el acuerdo que os protegía de la necesidad os está dejando a los dos solos. Y eso es justo lo que podríamos trabajar aquí.»*

### c) La indicación —y la honestidad sobre los límites—

La tercera sesión también sirve para decidir, con criterio, **si la terapia de pareja es lo indicado ahora**. Decir la verdad obliga a nombrar contraindicaciones y cautelas que el entusiasmo del principiante suele saltarse:

- **Violencia en curso:** ante violencia física o coacción, la terapia de pareja conjunta puede ser peligrosa (la sesión se usa como prueba y la víctima paga fuera lo que dijo dentro). Se valora seguridad primero y, muchas veces, abordajes separados. No es terreno para improvisar.
- **Affair activo en secreto / adicción activa / un pie fuera:** si uno mantiene en secreto una relación paralela o una adicción no parable, o ya ha decidido irse y usa la terapia de coartada, el trabajo conjunto se sostiene sobre falso. Aquí pesa la política de secretos que se fijó en la sesión 1.
- **Cuándo no es pareja lo que toca:** a veces lo que el material muestra es que uno necesita primero un proceso individual, o que lo que pide la familia es trabajo parental/familiar más que conyugal.

Honestidad de fondo: el terapeuta no garantiza salvar la relación. Su trabajo es ayudar a la pareja a entender su vínculo y a decidir desde la lucidez —a veces eso es reencontrarse, a veces es separarse mejor, sobre todo si hay hijos que van a seguir necesitando a los dos como padres aunque dejen de ser cónyuges—.

### d) La alianza con la pareja como unidad

La sesión 3 cierra cuando hay un «**nosotros tres**»: los dos y el terapeuta, mirando juntos el vínculo desde la tercera posición. Esa alianza —no con cada uno por separado, sino con la pareja como tercero pensante— es el verdadero resultado de las primeras sesiones. Es el embrión de lo que Morgan llama «*la pareja creativa*» (Morgan, 2019): dos que empiezan a poder pensar su relación en vez de solo sufrirla.

#### Errores frecuentes en la sesión 3

Devolver una formulación que suene a veredicto y deje a uno de culpable. Cerrar una indicación de pareja sin haber valorado violencia, secretos o «un pie fuera». Prometer resultados («os vais a reconciliar»). Construir alianza con uno y perder al otro. Confundir «mejorar la pareja» con «mantener la pareja a toda costa».

## 6 · La disciplina interna del terapeuta

Lo más difícil de la terapia de pareja no ocurre en lo que el terapeuta dice, sino en lo que sostiene dentro mientras escucha. Cinco disciplinas:

- **Empatía doble simultánea.** Estar de verdad con el mundo de cada uno sin que el otro se sienta soltado. Es la aplicación más exigente de la introspección vicaria de Kohut (§2). Se entrena; no sale solo.
- **Sostener la tercera posición.** Resistir la presión —constante— a caer dentro del conflicto como aliado o juez (Britton, §3). Cada vez que el terapeuta «sabe quién tiene razón», conviene sospechar que ha perdido el tercero.
- **Contener sin actuar.** Recibir la identificación proyectiva de los dos (la rabia, la desesperación, el desprecio que circulan) y *metabolizarla* en vez de devolverla en crudo. Es la función de «*continente*» de Bion: digerir lo que la pareja no puede pensar todavía y devolvérselo pensable (Bion, *Learning from Experience*, 1962). Winnicott lo nombraría como «*sostén*» (*holding*): ofrecer un entorno que aguanta sin derrumbarse (Winnicott, *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*, Hogarth, 1965).
- **No colusionar con la resistencia compartida.** Las parejas, además de pelear, cooperan inconscientemente para *no* ver ciertas cosas. El terapeuta puede ser arrastrado a esa ceguera pactada (a hablar siempre del hijo para no hablar de ellos, p. ej.). Detectar la colusión defensiva también va con él.
- **Usar la contratransferencia como dato, no como verdad.** Lo que el terapeuta siente informa de lo que circula entre ellos (Sandler, §5), pero solo si lo piensa en vez de creérselo. Por eso esto no se hace en soledad.

#### La regla que ninguna técnica sustituye

**Supervisión.** La identificación proyectiva en pareja es tan potente que el terapeuta queda dentro del campo sin notarlo. La supervisión es el lugar donde otro mira lo que uno ya no puede ver de su propia implicación. Empezar en terapia de pareja sin supervisión regular no es valentía: es quedarse ciego en el sitio donde más se necesita ver.

## 7 · Mapa de escuelas y desacuerdos

Qué integra esta guía, desde dónde, y dónde las escuelas chocan

Decir la verdad incluye decir que **aquí no hay una sola teoría, sino varias que miran lo mismo de forma distinta y a veces incompatible**. Esta guía es una *síntesis*, con la psicología del self como columna (porque es lo que pediste) y otras tradiciones integradas donde aportan. Conviene saber de dónde viene cada pieza y qué tensiones quedan abiertas.

## Las tradiciones que se han usado

- **Psicología del self (Kohut, Solomon):** el vínculo como red de funciones selfobject; la empatía como método. Mira la *necesidad* y la herida narcisista. Crítica que recibe: a veces subestima la agresión y el conflicto pulsional.
- **Relaciones objetales / kleiniana (Klein, Bion, Dicks, Britton, Scharff):** la identificación proyectiva, los objetos internos, el tercero. Mira el *conflicto* y lo inconsciente compartido. Crítica que recibe: puede sonar a atribuir «patología» y pasar por encima de la experiencia subjetiva.
- **Intersubjetiva / relacional (Stolorow & Atwood, Ogden, Ringstrom):** el vínculo (y la terapia) como campo co-creado entre subjetividades; rechaza la idea de un terapeuta «objetivo» fuera de la escena (Stolorow, Brandchaft & Atwood, *Psychoanalytic Treatment: An Intersubjective Approach*, Analytic Press, 1987; Ringstrom, *A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy*, Routledge, 2014). Tensión: relativiza la noción de tercero neutral que el §3 da por buena.
- **Teoría vincular (Puget & Berenstein):** la pareja como estructura con espacios propios (intra, inter y transubjetivo) y acuerdos inconscientes. Aporta el armazón de «el vínculo como paciente».
- **Sistémica (Bowen, y el puente de Willi):** la triangulación, los patrones circulares. No es psicoanálisis, pero describe con precisión cosas que el psicoanálisis también ve; por eso se integra, nombrándola como lo que es.

### La postura honesta

Ninguna de estas escuelas «tiene razón» sobre las demás. Un buen terapeuta de pareja no es ecléctico de cualquier manera: elige una columna (aquí, la psicología del self), entiende sus límites, y toma de las otras lo que ilumina su clínica sin pretender que todo encaja sin costuras. Lo que **no** es honesto es presentar una síntesis como si fuera un consenso que no existe. Este documento es una mirada entre varias posibles, argumentada y con sus fuentes a la vista —para que quien lo estudie pueda discutirla, no para que la crea.

---

## 8 · Bibliografía comentada

### Las fuentes — de dónde sale cada cosa

Metadatos (autor, título, año, editorial) verificados en junio de 2026. Para los clásicos se da la referencia estándar; las obras específicas de pareja se contrastaron una a una. Cuando en el cuerpo una expresión va entrecomillada, es un término técnico del autor citado, no una glosa libre.

## Psicología del self

- Kohut, H. (1959). «Introspection, Empathy, and Psychoanalysis». *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 7, 459–483. — Define la empatía como «introspección vicaria» y como método de observación. Base del §2.
- Kohut, H. (1971). *The Analysis of the Self*. Nueva York: International Universities Press. — Funciones del selfobject; réplica e idealización. Base del §2 y §4.3.
- Kohut, H. (1977). *The Restoration of the Self*. Nueva York: International Universities Press. — Amplía la teoría del self y añade la gemelaridad (twinship).
- Kohut, H. (1984). *How Does Analysis Cure?* (eds. A. Goldberg & P. Stepansky). Chicago: University of Chicago Press. — La empatía y la cura por reanudación del desarrollo del self.
- Solomon, M. F. (1989). *Narcissism and Intimacy: Love and Marriage in an Age of Confusion*. Nueva York: W. W. Norton. — Lleva a Kohut a la pareja: «no hay amor maduro en el que el objeto amado no sea también un selfobject». Eje del §2 y §4.3.

## Relaciones objetales · kleiniana · Tavistock

- Klein, M. (1946). «Notes on Some Schizoid Mechanisms». *International Journal of Psychoanalysis*, 27, 99–110. — Origen del concepto de identificación proyectiva. Base del §4.2.
- Bion, W. R. (1962). *Learning from Experience*. Londres: Heinemann. — Continente/contenido; la mente que metaboliza lo intolerable. Base del §4.2 y §6.
- Dicks, H. V. (1967). *Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Psychological Theory of Interaction*. Londres: Routledge & Kegan Paul (Tavistock). — La «personalidad marital conjunta»; la pareja como unidad de estudio. Base del §1 y §4.1/§4.4.
- Britton, R. (1989). «The Missing Link: Parental Sexuality in the Oedipus Complex». En J. Steiner (ed.), *The Oedipus Complex Today: Clinical Implications* (pp. 83–101). Londres: Karnac. — El espacio triangular y la tercera posición, formulados desde la pareja parental. Eje del §3.
- Britton, R. (2004). «Subjectivity, Objectivity, and Triangular Space». *Psychoanalytic Quarterly*, 73(1), 47–61. — Reelaboración del tercero y la realidad psíquica.
- Scharff, D. E. & Scharff, J. S. (1991). *Object Relations Couple Therapy*. Northvale, NJ: Jason Aronson. — Sistematiza el trabajo con identificación proyectiva en pareja. §4.2 y §5 (sesión 3).
- Ruszczynski, S. (ed.) (1993). *Psychotherapy with Couples: Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies*. Londres: Karnac. — Compendio de la clínica de pareja Tavistock.
- Morgan, M. (2019). *A Couple State of Mind: Psychoanalysis of Couples and the Tavistock Relationships Model*. Londres: Routledge. — «Estado mental de pareja», «pareja creativa» y «bloqueo proyectivo». Transversal: §1, §3, §4.2, §5.

## Intersubjetiva · relacional



- Stolorow, R. D., Brandchaft, B. & Atwood, G. E. (1987). *Psychoanalytic Treatment: An Intersubjective Approach*. Hillsdale, NJ: The Analytic Press. — El tratamiento como sistema intersubjetivo. §7.
- Stolorow, R. D. & Atwood, G. E. (1992). *Contexts of Being: The Intersubjective Foundations of Psychological Life*. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
- Ogden, T. H. (1994). «The Analytic Third: Working with Intersubjective Clinical Facts». *International Journal of Psychoanalysis*, 75, 3–19 (y *Subjects of Analysis*, Jason Aronson, 1994). — El «tercero analítico» co-creado. §3.
- Ringstrom, P. A. (2014). *A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy*. Nueva York: Routledge. — Enfoque relacional contemporáneo de la pareja. §7.

## Teoría vincular (psicoanálisis de pareja en castellano)

- Puget, J. & Berenstein, I. (1988). *Psicoanálisis de la pareja matrimonial*. Buenos Aires: Paidós. — «Lo vincular», acuerdos y pactos inconscientes, «zócalo inconsciente» de la pareja. Base del §1 y §4.1.
- Berenstein, I. (2004). *Devenir otro con otro(s)*. Buenos Aires: Paidós. — El vínculo como producción de subjetividad; la presencia del otro ajeno.

## Encuadre, técnica y sostén

- Bleger, J. (1967). «Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico». En *Simbiosis y ambigüedad*. Buenos Aires: Paidós. (Versión inglesa: *IJP*, 48, 511–519.) — El encuadre como «institución muda» depositaria. Base del §5 (sesión 1a).
- Sandler, J. (1976). «Countertransference and Role-Responsiveness». *International Review of Psychoanalysis*, 3, 43–47. — El paciente «asigna» un rol; la contratransferencia como dato. §5 (1d) y §6.
- Winnicott, D. W. (1965). *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. Londres: Hogarth. — «Sostén» (holding) y entorno facilitador. §6.

## Integraciones desde otras tradiciones (citadas como lo que son)

- Willi, J. (1982). *Couples in Collusion: The Unconscious Dimension in Partner Relationships*. Nueva York: Jason Aronson. (Orig. alemán: *Die Zweierbeziehung*, 1975.) — «Colusión»: enfoque combinado psicodinámico-sistémico. §4.1.
- Bowen, M. (1978). *Family Therapy in Clinical Practice*. Nueva York: Jason Aronson. — «Triangulación» (concepto sistémico, integrado con honestidad). §4.5.
- Fraiberg, S., Adelson, E. & Shapiro, V. (1975). «Ghosts in the Nursery». *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 14(3), 387–421. — «Fantasmas» (objetos del pasado que se repiten); origen en el vínculo padres-bebé, usado aquí como metáfora del matrimonio (matiz declarado en §4.4).

TWIM Project · Daniel Orozco Abia · Psicólogo General Sanitario CV11515 · Valencia

Documento de estudio interno · 9 jun 2026 · ejemplos clínicos hipotéticos · no sustituye la formación ni la supervisión clínica.